서울중앙지방법원 2025. 12. 9. 선고 2024가단5108791 판결

[보험금]

서 울 중 앙 지 방 법 원

판 결

사건	2024가단5108791 보험금
원고	A 소송대리인 변호사 강형구
피고(탈퇴)	B 주식회사
피고승계참가인	C 주식회사 소송대리인 변호사 허현희
변론종결	2025. 11. 4.
판결선고	2025. 12. 9.

주 문

1. 피고승계참가인은 원고에게 87,400,000원 및 이에 대하여 2021. 9. 15.부터 2024. 3. 26.까지는 연 6%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 소송비용은 피고승계참가인이 부담한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 어머니인 D는 2008. 12. 15.경 보험회사인 피고(탈퇴)(이하 '피고라 한다)와 피보험자 및 사망 외 수익자를 각 원고, 계약기간을 2008. 12. 15.부터 2023. 12. 15.까지로 정하여 암입원급여금(= 암 보장 개시일 이후 암으로 4일 이상 입원치료시, 3일 초과 1일당 가입금액 100,000원), 암진단급여금(= 암 진단시 가입금액 50,000,000원/최초 1회한, 1년 이내 50% 한도), 고액치료비 암진단급여금(= 암 보장개시일 이후 약관에 정한 고액치료비암으로 진단시, 최초 1회한, 가입금액 30,000,000원), 암수술급여금(= 암 보장 개시일 이후 암으로 수술시, 가입금액 3,000,000원)을 보장받는 내용의 E 보험계약(이하 '이 사건 보험계약'이라 한다)을 체결하였다.

나. 이 사건 보험계약에 적용되는 약관(이하 '이 사건 약관'이라 한다) 중 이 사건과 관련된 내용은 아래와 같다.

암진단급여금 보장, 암입원급여금 보장, 암수술급여금 보장 각 특별약관

제2조("암" 등의 정의 및 진단확정)

① 이 계약에 있어서 "암"이라 함은 제5차 한국표준질병사인분류에 있어서 악성신생물로 분류되는 질병([별표8] "악성신생물 분류표" 참조)을 말합니다.

⑥ 제1항 내지 제5항에서 암, 기타 피부암, 갑상샘암, 상피내암 또는 경계성종양의 진단확정은 해부병리 또는 임상병리의 전문의사자격증을 가진 자에 의하여 내려져야 하며, 이 진단은 조직검사, 미세침흡인검사 또는 혈액검사에 대한 현미경 소견을 기초로 하여야 합니다. 그러나 상기의 병리학적 진단이 가능하지 않을 때에는 암, 기타피부암, 갑상샘암, 상피내암 또는 경계성종양에 대한 임상학적 진단이 암, 기타피부암, 갑상샘암, 상피내암 또는 경계성종양의 증거로 인정됩니다. 이 경우에는 피보험자가 암, 기타피부암, 갑상샘암, 상피내암

또는 경계성종양으로 진단 또는 치료를 받고 있음을 증명할 만한 문서화된 기록 또는 증거가 있어야 합니다.

[별표8]

악성신생물 분류표

약관에 규정하는 암으로 분류되는 질병은 제5차 개정 한국표준질병사인분류(통계청 고시 제2007-4호, 2008. 1. 1. 시행) 중 다음에 적은 질병을 말합니다.

대상악성신생물	분류번호
눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부위의 악성 신생물	C69~C72

고액치료비암 진단급여금 보장 특별약관

제2조("고액치료비암" 등의 정의 및 진단확정)

① 이 계약에 있어서 "고액치료비암"이라 함은 [별표7](고액치료비암 분류표)에서 정하는 "식도의 악성신생물", "췌장(이자)의 악성신생물", "뼈 및 관절연골의 악성신생물", "뇌 및 중추신경계의 기타부위의 악성신생물", "림프, 조혈 및 관련조직의 악성신생물"을 말합니다.

② 제1항에서 "고액치료비암"의 진단확정은 해부병리 또는 임상병리의 전문의사자격증을 가진 자에 의하여 내려져야 하며, 이 진단은 조직검사, 미세침흡인검사 또는 혈액검사에 대한 현미경 소견을 기초로 하여야 합니다. 그러나 상기의 병리학적 진단이 가능하지 않을 때에는 "고액치료비암"에 대한 임상학적 진단이 "고액치료비암"의 증거로 인정됩니다. 이 경우에는 피보험자가 "고액치료비암"으로 진단 또는 치료를 받고 있음을 증명할 만한 문서화된 기록 또는 증거가 있어야 합니다.

[별표7]

고액치료비암 분류표

약관에 규정하는 화상으로 분류되는 질병은 제5차 개정 한국표준질병사인분류(통계청 고시 제2007-4호, 2008. 1. 1. 시행) 중 다음에 적은 질병을 말합니다.

대상질병명	분류번호
4. 뇌 및 중추신경계통의 기타부위의 악성신생물	C70-C72
- 수막의 악성신생물	C70
- 뇌의 악성신생물	C71
- 척수, 뇌신경 및 중추신경계통의 기타부위의 악성신생물	C72

다. 제5차 개정 한국표준질병사인분류(이하 '한국표준질병사인분류'라 한다) 중 이 사건과 관련된 내용은 아래와 같다.

II. 신생물(C00-D48)

이 장은 다음과 같은 신생물의 광범위한 분류를 포함한다 :

C00-C97 악성 신생물

C00-C75 림프, 조혈 및 관련조직을 제외한 부위의 원발성이라고 정해졌거나 또는 가정되는 악성신생물

C69-C72 눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타부위

주:

3. 형태

악성신생물에는 수개의 주요 형태(조직)군이 있다 : II장에서 신생물은 행동양식에 대하여 넓은 분류내에서 주로 부위에 따라 분류되어 있다.

몇가지 예외적인 경우에서 형태가 항목 및 세항목의 제목에 나타난다. 신생물의 조직학적 형태의 분류를 원하는 사람들을 위하여 포괄적인 별도의 형태분류번호(ICD-O)가 (1021~1054)쪽에 제시되어 있다. 이 형태 분류번호는 국소학 및 형태의 독립된 분류번호체계를 제공하는 이원 분류로 구성된 종양학적 질환의 국제질병분류(ICD-O)에서 유래된다.

형태 분류번호는 6자리숫자 분류번호인데 처음 4자리숫자는 조직학적 형태의 분류에 쓰이고 5째자리수는 행동양식번호이고(원발성 악성, 속발성(전이성) 악성, 상피내, 양성, 양성인지 악성인지 불확실한) 6째자리수는 고형종양에 대한 등급분류번호(분화도)이고 림프종이나 백혈병에 대하여도 특별한 분류번호로 사용된다.

악성신생물(C00-C97)

림프, 조혈 및 관련조직을 제외한 부위의 원발성이라고 정해졌거나 또는 가정되는 악성신생물(C00-C75)

눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부위의 악성신생물(C69-C72)

C72 척수, 뇌신경 및 중추 신경계통의 기타 부위의 악성신생물

C72.0 척수(Spinal cord)

제4편 신생물의 형태분류

종양학에 대한 국제질병분류(ICD-O)의 개정 제3판이 2000년에 발행되었고 제2장과 연결하여 사용하기 원하는 사람들을 위하여 여기에 다시 제정된 신생물 형태의 부호화된 명명법을 포함하였다.

형태 분류번호는 5단위 숫자로 구성된다: 처음 4자리수는 신생물의 조직학적 형태를 표시하고 사선 뒤의 5째 자리수는 그 행동양식을 표시한다. 그 행동양식 분류번호는 다음과 같다.

/0 양성

/1 양성 또는 악성여부가 불확실한
경계성 악성
낮은 악성 잠재성
불확실한 악성 잠재성

/2 정상소재의 암종
상피내
비침윤성
비침범성

/3 악성, 원발부위

/6 악성, 전이부위
악성, 속발부위

/9 악성, 원발부위 또는 속발부위 여부가 불확실한

다음의 명명법에서 형태 분류번호는 신생물의 조직학적 형태에 적합한 행동양식 분류번호를 포함한다; 만일 다른 보고자료가 이것을 적합하게 하면 이 행동양식 분류번호는 변경되어야 한다. 예를 들면, 척삭종은 악성으로 간주되고 따라서 분류번호 M9370/3으로 분류된다; 그러나, 용어가 "양성 척삭종"이면 M9370/0으로 분류되어야 한다. 마찬가지로 얕은 확산성 선암종(M8143/3)이 "비침습성"으로 기술되었을 때에는 M8143/2로 분류되어야 하고, 악성 흑색종(M8720/3)은 "속발성"으로 기술되었을 때 M8720/6으로 분류되어야 한다.

다음 표는 행동양식 분류번호와 제2장의 다른 부분과의 상응관계를 나타낸다.

행동양식 분류번호	제2장 항목
/0 양성 신생물	D10-D36
/1 불확실한 또는 알려지지 않은 성격의 신생물	D37-D48, D76.0
/2 상피내 신생물	D00-D09
/3 원발성으로 기재 또는 추정된 악성 신생물	C00-C76 C80-C97 D45,D46,D47.1 D47.3, L41.2
/6 속발성으로 기재 또는 추정된 악성 신생물	C77-C79

라. 원고는 2021. 7. 4.부터 2021. 7. 23.까지 서울대학교병원에 입원하여 2021. 7. 7. 위 병원에서 척수말단 종양(이하 '이 사건 종양'이라 한다) 제거술을 받고 그 조직검사를 실시하였는데 병리진단결과, 'Myxopapillary ependymoma(점액유두상 뇌실막세포종), WHO grade 2'로 진단되었다. 서울대학교병원 의사 F은 2021. 8. 24.

원고에 대하여 병명(최종진단) : Spinal cord glioma(척수신경교종), 국제질병 분류기호를 'C72.0'으로 진단(이하 '이 사건 진단'이라 한다)하였다.

마. 원고는 2021. 8. 30. 피고에게 이 사건 종양을 사고원인으로 하여 이 사건 보험계약에 따른 보험금청구를 하였으나 피고를 이를 거절하였다.

바. 한편 금융위원회는 2025. 9. 3. 금융산업의 구조개선에 따른 법률 제14조 제2항에 따라 피고의 모든 보험계약 및 자산을 피고승계참가인이 이전받는 '계약이전결정'을 하였다. 이에 따라 피고승계참가인은, 피고승계참가인이 피고의 모든 보험계약상 지위 및 영업 일체를 이전받았다고 주장하며 이 사건 소 계속 중인 2025. 9. 22. 승계참가를 하였고, 피고는 원고의 동의를 받아 이 사건 소송에서 탈퇴하였다(이하 '피고'와 '피고 승계참가인'을 구분하지 않고 모두 '피고'로 통칭한다).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증(각 가지번호 포함, 이하 같다), 제12, 14호증, 을 제3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고

이 사건 종양에 대한 조직검사결과가 점액유두상 뇌실막세포종으로 진단되었고, 한국표준질병사인분류에 의하면, 위 진단에 해당하는 분류번호는 D43.4로 이에 상응하는 신생물 형태에 대한 행동양식 분류기준에 의하면, 이는 '불확실한 또는 알려지지 않은 성격의 신생물'에 해당한다. 그러나 한국표준질병사인분류에 의하더라도, 한국표준질병사인분류에서 신생물 형태를 악성신생물로 분류하는 기준으로 정한 위 행동양식 분류번호는 절대적 기준이 아니고, 적합성이 인정되는 '다른 보고자료'에 의하여 그 행동양식 분류번호가 변경될 수 있다. 이 사건 진단은 위 '다른 보고자료'에 해당하므로, 이 사건 종양은 이 사건 약관에서 정한 '암' 및 '고액치료비암'에 해당한다.

나. 피고

이 사건 종양은 조직검사결과, 점액유두상 뇌실막세포증으로 진단되었으므로, 한국표준질병사인분류에서 정한 질병코드가 D43.4이어서 한국표준질병사인분류의 행동양식 분류기준상 양성신생물로 보아야 한다. 따라서 이 사건 종양은 이 사건 약관에서 정한 악성신생물로 볼 수 없고, 이 사건 진단은 임상의사가 병리전문의의 위 진단과 다르게 한 것이므로, 이 사건 진단이 있다고 하여 이 사건 종양에 대하여 이 사건 약관에서 정한 암의 진단확정이 있었다고 볼 수 없다.

3. 판단

가. 이 사건 종양이 이 사건 약관에서 정한 '암(악성신생물)'에 해당하는지 여부

앞서 든 증거들과 갑 제9 내지 11호증, 제13, 15호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 서울대학교병원 신경외과 의사 F 및 통계청장에 대한 각 사실조회결과, G단체 의료감정원에 대한 진료기록감정촉탁결과 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인

정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 종양은 이 사건 약관에서 '암' 및 '고액치료비암'으로 각 정의한 '척수 부위의 악성신생물'(C72.0)에 해당한다고 봄이 타당하다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 보험계약에 따라 이 사건 종양을 보험사고로 한 보험금을 지급할 의무가 있다.

1) 원고는 2021. 6. 15. 실금, 실변 증상으로 H병원에 내원하여 2021. 6. 17. 위 병원에서 골조직 표본 검사를 받았다. 위 병원 병리의사 I, J은 원고에 대하여 'Myxopapillary ependymoma(점액유두상 뇌실막세포종), WHO grade II'로 진단하였고, H병원 의사 K은 2021. 6. 25. 원고의 질병명을 '척수의 양성 신생물'로, 한국표준질병 분류번호를 'D33.4'로 진단하였다.

2) 이후 원고는 서울대학교병원에 입원하여 이 사건 종양에 대한 조직검사를 실시하였고, 위 병원의 병리의사 L는 위 H병원의 조직검사결과와 동일하게 'Myxopapillaryependymoma(점액유두상 뇌실막세포종), WHO grade II'로 진단하였다.

3) Myxopapillary ependymoma(점액유두상 뇌실막세포종)는 한국표준질병사인분류표에 의하면, 신생물 분류번호가 D43.4이고, 그에 상응하는 행동양식 분류번호는 '1(불확실한 또는 알려지지 않은 성격의 신생물)'로 부여된다. 그런데 원고에 대한 위 병리검사를 담당한 병리의사들은 모두 원고를 '점액유두상 뇌실막세포종'으로 진단하면서 그 옆에 'WHO grade II'를 병기하였다. 이에 관하여 진료기록감정촉탁의는, '전 세계의 병리의사들은 WHO classification 최신판을 기준으로 종양을 진단하고, 중추신경계 종양을 진단할 때 통일된 등급체계를 이용하며 이는 CNS WHO grade 1, 2, 3, 4로 구분하여 나타낸다. 그와 별도로 중추신경계 종양은 ICD-O 코드를 통해 분류하고 행태(behavior) 코드를 부여받는데, ICD-O 행태(behavior) 코드는 WHO grade 1인 경우, /0 Bengin 또는 /1 uncertain whether benign or malignant 등급이 부여되고, WHO grade 2 이상인 경우 대체로 /3 Malignant로 부여되지만 일부 종양에서는 예외가 있다'고 밝혔다.

4) 이 사건 진단에 의하면, 서울대학교병원 의사 F은 이 사건 종양을 척수 악성신생물 병명으로 진단하고, 분류기호를 C72.0으로 진단하였다. 이에 대하여 진료기록감정촉탁의는, '현재 가장 최신의 세계보건기구의 종양학 국제질병분류(ICD-O) 3rd edition 코드 시스템은 C로 시작하는 위치 코드, 3~4자리의 숫자로 이루어진 조직학적 코드, /숫자로 이루어진 행태코드로 이루어져 있다. WHO의 ICD-O 가이드라인에 따르면 ICD-O 코드의 C 코드는 ICD-10의 D코드와 매칭될 수도 있다. 우리가 일반적으로 사용하는 한국표준질병사인분류 코드는 1992년에 도입되어 30년 이상 사용되어 온 ICD-10을 기반으로 제작되었다.'고 밝히었다. 위 의견의 근거가 된 해당 자료에 의하면, ICD-O 코드의 'C 코드 00-80'은 그 행태코드 '/2, /0, /1'에 따라 ICD-10의 D코드 '00-09', '10-36', '37-48'과 각 매칭이 되고, 이는 ICD-10을 기반으로 제작된 한국표준질병사인분류 제2장(신생물) 항목의 D코드 '00-09', '10-36', '37-48'에 각 상응하는 제4편(신생물의 형태분류)에 따른 행동양식 분류번호인 /2, /0, /1과도 일치한다. 결국 한국표준질병사인분류 제2장에서 신생물 항목별로 부여하는 코드 중 D로 시작하는 일부 코드는, ICD-O 코드에서 C로 시작하는 종양의 위치코드와 그에 상응하는 행태코드를 결합하여 부여한 것임을 알 수 있다.

5) 위에서 본 ICD-O 코드와 한국표준질병사인분류의 신생물 항목별 부여 코드와의 상관관계에 비추어 보면, 원고에 대한 각 병리진단결과인 Myxopapillary ependymoma(점액유두상 뇌실막세포종)는 ICD-O의 위치코드상 C72.0에 해당하고, 그 조직학적 코드와 행태코드가 M9394/1에 해당하므로, 한국표준질병사인분류 제2장에 따른 신생물

항목 코드는 D43.4로 볼 수 있다. 한편 이 사건 진단을 내린 F 의사는, 이 사건 진단서에서 위 병리진단결과인 'Myxopapillary ependymoma(점액유두상 뇌실막세포종)이 악성 종양에 해당한다'고 소견을 밝히었고, 그 근거에 관하여 'Myxopapillaryependymoma는 뇌-척수종양의 병리진단에 널리 쓰이는 조직 grade에서 2등급에 해당하고, 보통 1등급은 질환에 따라 양성이나 경계성으로 판단하며 2등급부터는 악성으로 간주하고 치료한다'고 답변하였다. 따라서 의사 F이 이 사건 진단에서 이 사건 종양에 대하여 부여한 분류기호 C72.0은 Myxopapillary ependymoma(점액유두상 뇌실막세포종)에 대한 ICD-O의 위치코드와는 일치하나, 이에 대하여 한국표준질병사인분류에서 명명한 행태 분류번호에 포함되는 행동양식 분류번호 /1(불확실한 또는 알려지지 않은 성격의 신생물)과 달리 위 행동양식 분류번호를 /3(원발성으로 기재 또는 추정된 악성신생물)으로 평가한 것에 따른 것으로 볼 수 있다.

6) 한국표준질병사인분류 제4편에서 정한 신생물 형태의 부호화된 명명법에 의하면, 신생물의 형태분류에 관한 형태분류번호는 신생물의 조직학적 형태에 적합한 행동양식 분류번호를 포함하는데, 만일 '다른 보고자료'가 이것을 적합하게 하면, 해당 행동양식 분류번호는 변경되어야 한다고 정하고 있다. 그 의미에 관하여 통계청장은 "신생물 형태의 부호화된 명명법에 수록된 행동양식 분류번호는 고정 불변한 것이 아니라 '다른 보고자료'에 따라 변경될 수 있다는 내용으로 볼 수 있고, 이 때의 '다른 보고자료'는 의사가 기록한 진단명을 의미한다. 의사가 병리검사결과를 토대로 한국표준질병사인분류에 기재된 행동양식 분류번호와 다른 진단을 한다면 이러한 진단도 '다른 보고자료'에 해당하게 된다"는 의견을 밝힌 바 있다.

7) 앞서 본 것과 같이 원고에 대한 병리검사결과, 그 진단명인 Myxopapillaryependymoma(점액유두상 뇌실막세포종)는 WHO grade II에 해당하고, 해당 등급에 대한 국제질병분류(ICD-O)의 행태코드는 악성 종양인 '/3'에 해당한다. 이 사건 진단을 한 의사 F은 'Myxopapillary ependymoma는 양성 종양으로 볼 수 없는 높은 재발률과 전이가 관찰되어 일반적으로 악성으로 판단하고 치료하고 있고, 위 병리검사결과의 'WHO grade II'를 고려하여 악성으로 간주하고 치료한다'고 밝히면서, '원고의 임상양상, MRI 소견, 수술소견 및 병리보고서를 종합하여 이 사건 진단을 하였고, 여러 가지 질병의 양상과 검사결과가 이 사건 진단에 합당하다고 신경외과 의사로서의 경험과 지식에 근거하여 판단하였다'고 의견을 밝히었다.

8) 진료기록감정촉탁의 또한 'Myxopapillary ependymoma는 기존 CNS WHO grade 1 등급의 종양으로 여겨졌으나, 2020년 발표된 cIMPACT-NOW update7에서 CNSWHO grade 2의 종양으로 변경되었으며 그에 따라 2021년 출간된 WHO classfication of tumors of central nervous system fifth edition에서 WHO grade 2로 최종 정정되었다. 그 근거는 2015년 M에 발표된 ependymoma의 임상경과에 대한 다기관연구이다. 해당 연구에 따르면, Myxopapillary ependymoma의 임상경과와 생존율은 WHO grade 2의 ependymoma와 차이가 없었다. WHO grade 2의 ependymoma는 KCD-8 코드 C71.__에 해당하며 ICD-O코드는 9391/3에 해당하는 악성종양이다. 따라서 Myxopapillary ependymoma의 임상경과와 생존율이 WHO grade 2의 악성인 ependymoma와 차이가 없었으므로, 환자의 치료를 담당하는 F 의사는 Myxopapillaryependymoma를 악성으로 간주하고 치료할 수 있다'고 의견을 밝히었다.

9) 의사 F은 이 사건 진단에서, '이 사건 종양이 악성종양으로, 원고에 대하여 방사선 치료를 예정하고 있다'고 진단하였고, 이 사건 종양을 악성으로 진단한 이유에 관한 N 주식회사의 질의에 대하여 이 법원의 사실조회에 대한 위 답변

내용과 동일하게 답하면서 '원고에 대한 수술시 경계면이 불확실한 경우로 재발가능성이 높아 수술 후 방사선을 시행하였다'고도 밝힌 사실이 있으며, 원고는 수술 후인 2021. 7. 29.경부터 2021. 8. 27.까지 서울대학교병원에서 이 사건 종양 치료를 위한 방사선치료를 받았다.

10) 위에서 본 여러 사정을 고려하면, 이 사건 진단은, 임상의사인 F이 원고에 대하여 병리 전문의사가 한 조직검사결과 등을 토대로 한 것이어서 그 객관성과 합리성을 갖추었다고 판단된다. 따라서 의사 F이 Myxopapillary ependymoma의 분류번호를 한국표준질병사인분류의 행동양식 분류번호와 달리 악성 신생물의 행동양식으로 분류하여 'C72.0'으로 부여한 이 사건 진단은 한국표준질병사인분류에서 신생물 형태의 분류번호에 포함되는 행동양식 분류번호가 변경될 수 있는 사유로 인정한 '다른 보고자료'에 해당한다고 봄이 타당하다. 그리고 같은 이유에서 이 사건 진단에 의하여, 이 사건 약관에서 암 및 고액치료비암의 진단확정의 주체가 되는 해부병리 또는 임상병리의 전문의사 자격증을 가진 자에 의한 조직검사 등을 통한 암 및 고액치료비암의 진단확정이 있었다고 봄이 타당하다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2011다13968, 13975 판결, 대법원 2018. 10. 12. 선고 2017다268616 판결 등 참조).

나. 소결론

피고가 이 사건 보험계약에 따라 원고에게 보험금을 지급할 의무가 있음은 위에서 보았다. 따라서 피고는 원고에게 보험금 총 87,400,000원[= 암진단급여금 50,000,000원 + 고액치료비암진단급여금 30,000,000원 + 암수술급여금 3,000,000원 + 암입원급여금 4,400,000원][1] 및 이에 대하여 원고가 이 사건 보험금을 청구한 2021. 8. 30. 이후로서 원고가 구하는 2021. 9. 15.부터 이 사건 소장 부본 송달일인 2024. 3. 26.까지는 상법이 정한 연 6%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 윤양지

---

1 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 이 사건 종양의 치료를 위하여 2021. 6. 16.부터 2021. 9. 29.까지 H병원, 서울대학교병원 및 O요양병원에 총 48일 입원한 사실을 인정할 수 있고, 4일 이상 치료시 3일 초과 1일당 100,000원의 암입원급여금을 지급하므로, 4,400,000원[= (48일−4일) × 100,000원]이 된다.